Cabinet de dermatologie Es-Senia

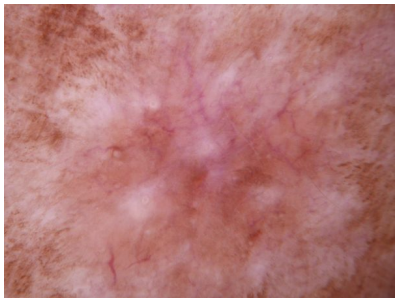
تقرير المساعدة على الفرز — آفة جلدية

dermIA الإصدار 2.0.0 · النموذج ham10000-bcn20000-m5-v3 الإصدار 3.0.0 (الملف: كامل)

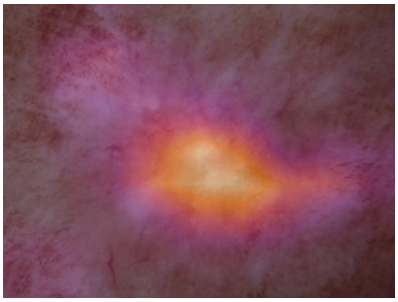
المريض	P-2026-0424	تاريخ التحليل	07:55 02/11/2026
العمر (بالسنوات)	60	طلب التحليل	Dr Karim Haddad
الجنس	ذكر	الموضع	الطرف العلوي
الآفة المتابعة	رقم 1	عتبات القرار	الأصلية

إحالة إلى الطبيب

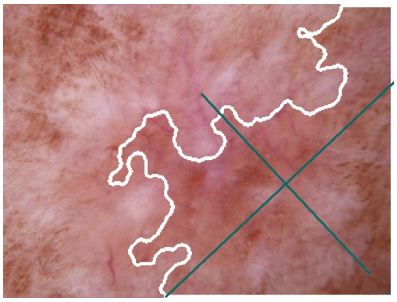
نتيجة غير مؤكدة: الذكاء الاصطناعي يمتنع عن الحكم
تبقى عدة تشخيصات محتملة عند مستوى الثقة المضمون. يجب أن يفحص الطبيب هذه الحالة.



الصورة المحللة



المناطق الأكثر تأثيرا (Grad-CAM، «تقرن حميد»)



الحدود والمحاور المستخدمة في معايير ABCD

الاحتمالات المقدرة

التشخيص	الاحتمال	ضمن المجموعة المضمونة*
تقرن حميد	74,9%	نعم
تقرن سفعي / داء بوين	17,5%	نعم
ورم ليفي جلدي	7,1%	نعم
ورم ميلانيني	0,4%	
سرطانة الخلايا القاعدية	0,1%	
وحمة ميلانينية	0,0%	
آفة وعائية	0,0%	

* المجموعة المطابقة (طريقة موندريان، ألفا = 0,10): تحتوي على التشخيص الصحيح باحتمال لا يقل عن 90% لكل فئة، بافتراض أن الحالات تشبه بيانات المعايرة. يتخذ قرار الورم الميلانيني إذا كان p(mel) ≥ 0,03 (نسبة التكلفة R = 10).
عتبات النموذج الأصلية، معايرة على مجموعة المعايرة الخاصة به.

معايير ABCD الآلية (استرشادية)

المعيار	القياس	التفاصيل
A — عدم التناظر	2/2	محاور رئيسية غير متناظرة (الشكل أو الألوان)
B — الحواف	1/8	قطاعات ذات حافة حادة
C — الألوان	2/6	بني داكن، أزرق رمادي
D — القطر	14,3 مم	أكثر من 6 مم

تنبيه: تلامس الآفة حافة الصورة: المعايير A وB وD أقل موثوقية.
قياسات آلية استرشادية: على مجموعة الاختبار من HAM10000 لا يميز كل منها بين الورم الميلانيني والوحمة إلا بشكل محدود (AUC من 0,66 إلى 0,73). وهي لا تغني عن الفحص بالمنظار الجلدي.

المراجعة الطبية

لم يراجعها طبيب بعد.

توقيع الطبيب: _____

تنبيه. أعدت هذه الوثيقة بواسطة أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وهي لا تعد تشخيصا ولا تغني عن الفحص السريري ولا عن الفحص النسيجي. حالة النموذج: بحث — استخدام غير تجاري — ليس جهازا طبيا. بيانات التدريب: HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) + BCN20000 (Hernández-Pérez et al., Sci Data 2024, doi:10.1038/s41597-024-03387-w) — الترخيص CC BY-NC 4.0 (غير تجاري).